中風無意識患者照護 SOP

繁體中文 / 印尼文（Bahasa Indonesia）雙語版

適用對象：中風且無意識（臥床、無法自主表達與吞嚥）之被照顧者

使用方式：每章節獨立一頁，可依需求列印所需頁數，護貝後張貼於床邊

目錄

1. 每日作息與醫療照護時程表
2. 鼻胃管灌食回抽 SOP
3. 壓瘡預防與翻身減壓 SOP
4. 管路留置照護（鼻胃管、尿管）
5. 緊急警訊判斷與通報標準
6. 【床頭卡】鼻胃管灌食回抽（雙語版）
7. 【床頭卡】2小時翻身減壓（雙語版）
8. 【雙語 SOP 1】生命徵象量測與警訊通報
9. 【雙語 SOP 2】鼻胃管給藥與防塞管
10. 【雙語 SOP 3】床上擦澡、口腔與皮膚照護
11. 【雙語 SOP 4】導尿管與排泄照護
12. 印尼文日常照護常用單字速查卡

一、每日作息與醫療照護時程表

無意識中風患者仰賴鼻胃管（NG tube）灌食，一般採每 3–4 小時灌食一次：

時間	項目（中 / 印尼文）	核心操作標準與注意事項
06:30–07:30	晨間量測、口腔與會陰清潔 (Tensi, Bersih Mulut & Kemaluan)	• 量測血壓、脈搏、體溫、血氧（SpO2）並記錄 • 口腔海綿棒清潔 • 檢查尿布與尿袋尿量、顏色
07:30–08:30	第 1 次管灌與給藥 (Sonde Makan 1 & Obat)	• 抬高床頭 30–45 度 • 灌食前確認鼻胃管刻度並回抽胃液 • 藥物磨粉溶解後管灌，溫水 20–30ml 沖管
09:30–10:30	翻身、被動關節運動 PROM (Miringkan Badan & Gerakan Sendi)	• 姿勢變換（左側躺 30 度，背部置三角墊，兩膝夾枕頭） • 四肢各關節被動伸展各 10–15 次
11:00–12:00	第 2 次管灌餵食 (Sonde Makan 2)	• 同灌食流程，灌食後保持床頭抬高 30–60 分鐘
12:00–14:00	翻身（右側躺）與看護午休 (Ganti Posisi & Waktu Istirahat)	• 12:00 翻身後，長輩午休，看護同步休息
14:30–15:30	擦澡清潔、更換衣物 (Lap Badan / Mandi di Tempat Tidur)	• 溫水床上擦澡，注意腋下、腹股溝、頸部皺褶 • 擦乾塗抹潤膚乳，檢查皮膚壓紅
15:30–16:30	第 3 次管灌餵食 (Sonde Makan 3)	• 灌食與給藥（如有下午藥）
17:30–18:30	翻身、拍背排痰 (Tepuk Punggung & Sedot Lendir)	• 側臥下空心掌拍背，由下往上、由外往內 • 有痰音時依指示抽痰
19:00–20:00	第 4 次管灌與晚藥 (Sonde Makan 4 & Obat)	• 灌食流程同上，給予夜間藥物
20:30–21:30	睡前護理、翻身就寢 (Siap Tidur & Cek Popok)	• 更換夜用高吸收尿布，尾骶骨塗氧化鋅隔離 • 拉起床欄，確認氣墊床交替充氣正常
夜間 01:00/04:00	夜間巡視與翻身 (Ganti Posisi Malam)	• 至少每 3–4 小時輕柔翻身減壓

二、鼻胃管灌食回抽 SOP

⚠️ **灌食不慎引發吸入性肺炎是致死高風險因子，必須嚴格執行！**

步驟一：體位與管路查核（嚴禁平躺灌食）

- 床頭搖高 **30–45 度**（半坐臥姿）
- **確認刻度**：檢查鼻胃管固定於鼻孔處的公分數刻度，若脫出超過 **2 公分**切勿灌食，立即回報家屬
- **回抽確認（Aspirasi）**：
  - ✅ 抽出胃液呈草綠色 / 淡黃色清澈 → 位置正確，可灌食
  - ⚠️ 回抽物超過 **100ml** 或見未消化殘渣過多 → 暫停本餐，胃液回推，休息 1 小時後再評估
  - 🚨 抽到**鮮血或咖啡渣色物質** → **立即停止灌食並通知家屬送醫！**

步驟二：重力灌食與給藥（切忌手推加壓）

- 灌食針筒高度維持在臉部上方約 **30–45 公分**，靠地心引力緩慢流入（250ml 約需 10–15 分鐘）
- **避免空氣進入**：配方液快見底時即刻倒入下一劑或溫水
- **藥物管灌**：口服藥分開磨粉徹底溶解，先給藥後沖溫開水 **30–50ml** 洗淨管壁

步驟三：灌後留置與觀察（預防逆流嘔吐）

- 灌食結束後，維持床頭抬高 **30–45 度**至少 **45–60 分鐘**
- 灌食後 **1 小時內**：🚫 嚴禁平躺、🚫 嚴禁拍背、🚫 嚴禁劇烈翻身
- 觀察是否有溢奶、臉色發紫（發紺）、劇烈喘鳴

三、壓瘡預防與翻身減壓 SOP

每 2 小時定時翻身減壓

- 採 **30度側臥位**，**絕不可呈 90 度側壓**（否則大轉子骨承受巨大壓力）

枕頭支撐點

- **背部**：後方塞三角海綿枕支撐背脊
- **兩膝之間**：夾小枕頭（避免骨頭互相摩擦磨破）
- **腳跟**：下方墊高**懸空**，不可直接壓在床面

氣墊床日常檢查

- 每日觸摸氣墊床條管是否有「一充一消」交替循環（波浪運作）
- 氣壓調節需符合長輩體重，不可打到最硬也不可軟到觸底（Bottoming out）

被動關節活動（PROM，每日 2 次）

- 輕柔活動肩、肘、腕、指，以及髖、膝、踝關節
- 每個關節做曲折、伸展、內外旋轉，動作緩慢不可硬扳，遇阻力即停
- 手心放置握固球或捲狀小毛巾，防手指肌肉強直痙攣屈曲

四、管路留置照護（鼻胃管、尿管）

鼻胃管（NG Tube）

- 每天更換鼻部透氣膠帶（宜工字型或人字型固定），並輕微旋轉管子防管壁黏連潰瘍
- 每日以棉花棒沾水清潔鼻腔周圍分泌物

導尿管與尿袋（Foley Catheter）

- **尿袋位置永遠低於膀胱**（低於床緣），防止尿液逆流引發腎臟與泌尿道急性感染
- 尿管避免扭曲、摺疊或受下肢壓迫
- 尿量達尿袋的 **1/2 至 2/3** 時必須排空，不可放至全滿
- 每日以優碘或溫水由尿道口向外**單向**擦拭消毒（會陰沖洗）

五、緊急警訊判斷與通報標準

中風無意識患者無法呼痛，需仰賴細微生理徵象判斷：

異常徵兆	潛在危機	應變處置標準
血氧 < 92% 或喘鳴呼吸急促	吸入性肺炎 / 呼吸道阻塞	1. 立即抬高床頭、清除口鼻分泌物或抽痰 2. 戴上氧氣鼻導管 3. **立即叫 119 送醫並通知家屬**
突發單側 / 雙側瞳孔放大或痙攣抽搐	二次中風 / 腦出血 / 癲癇	1. 保持側臥防口水嗆入，移開身旁硬物 2. **不可硬塞東西入口中** 3. 立即叫 119 送醫
體溫 > 38.2°C 伴隨畏寒發抖	肺炎、泌尿道感染或菌血症	1. 立即回報家屬 2. 檢查尿液是否混濁、痰量是否變黃稠 3. 依醫囑準備退燒藥塞劑或就醫
回抽胃液呈暗紅色、黑色咖啡渣樣	急性胃出血 / 應激性潰瘍	1. **立即停止灌食與管灌給藥** 2. 拍照留存回抽液外觀 3. 即刻通報家屬送醫
尾骶骨 / 腳跟皮膚發黑或破皮見組織液	第 3/4 級深度壓瘡潰瘍	1. 該部位**嚴禁再次受壓**（架空懸空） 2. 切勿自行塗牙膏或偏方藥膏 3. 拍照回報，安排居家護理師換藥清創

六、【床頭卡】鼻胃管灌食回抽（繁中 / 印尼文）

📌 BAGIAN 1: PROSEDUR PEMBERIAN MAKANAN LEWAT SELANG LAMBUNG (NGT)

⚠️ **嚴禁平躺灌食！ / DILARANG KERAS MEMBERI MAKAN DALAM POSISI TIDUR TERLENTANG!**

步驟 1：準備與回抽確認 / Langkah 1: Persiapan & Cek Sisa Lambung

繁體中文：

- 將床頭搖高至 30°～45°（半坐臥姿勢）
- 檢查鼻孔外的管路刻度，確認管子沒有滑脫（若滑脫超過 2cm 請勿灌食，立即通知雇主）
- 用大針筒反抽胃液（回抽）：
  - ✅ 透明/淡黃/淡綠色 且胃殘餘量少於 100ml → 正常，可灌食
  - ⚠️ 胃殘餘量大於 100ml → 暫停本餐，休息 1 小時後再抽
  - 🧯 抽出黑色、咖啡渣色或鮮血 → **立即停止灌食！拍照並通知雇主送醫！**

Bahasa Indonesia：

- Naikkan kepala tempat tidur setinggi 30°–45° (posisi setengah duduk)
- Periksa tanda garis (cm) selang NGT di dekat hidung (jika keluar > 2 cm, JANGAN beri makan, lapor majikan)
- Gunakan spuit besar untuk menarik cairan lambung (aspirasi):
  - ✅ Cairan kuning muda/bening/hijau & sisa < 100ml → Normal, mulai beri makan
  - ⚠️ Sisa makanan > 100ml → Tunda makan 1 jam, periksa kembali
  - 🧯 Cairan hitam/cokelat ampas kopi/darah segar → **SEGERA STOP! Foto dan lapor majikan!**

步驟 2：重力灌食與洗管 / Langkah 2: Proses Makan & Bilas Selang

繁體中文：

- 拔掉針筒活塞，管口朝上，維持高度在臉部上方約 30～45 公分
- 讓配方奶靠地心引力緩慢流入，**不可用針筒活塞硬推加壓**
- 快流完前倒入藥物（徹底磨粉攪勻），最後 30～50 ml 溫開水沖洗管路

Bahasa Indonesia：

- Lepaskan pendorong spuit, pegang tabung setinggi 30–45 cm di atas wajah pasien
- Biarkan susu mengalir alami dengan gravitasi, **JANGAN ditekan paksa**
- Sebelum habis, masukkan obat yang sudah digerus, terakhir bilas 30–50 ml air hangat

步驟 3：灌後姿勢與觀察 / Langkah 3: Posisi Setelah Makan & Observasi

繁體中文：

- 灌食結束後，床頭維持抬高 30°～45° 至少 45～60 分鐘
- 灌食後 1 小時內：🚫 嚴禁平躺、🚫 嚴禁拍背、🚫 嚴禁劇烈翻身
- 觀察臉色是否發紫或喉嚨有痰音溢出

Bahasa Indonesia：

- Pertahankan kepala tempat tidur 30°–45° minimal 45–60 menit

- Selama 1 jam setelah makan: DILARANG telentang, DILARANG tepuk punggung, DILARANG balik badan mendadak
- Perhatikan apakah wajah/bibir pucat/kebiruan atau terdengar suara dahak

七、【床頭卡】2 小時翻身減壓（繁中 / 印尼文）

📌 BAGIAN 2: TEKNIK MIRING BADAN TIAP 2 JAM & MENCEGAH LUKA TEKAN

⏰ 翻身循環時鐘 / Jadwal Rotasi Posisi

08:00 左側躺 ➔ 10:00 平躺 ➔ 12:00 右側躺 ➔ 14:00 平躺 ➔ 16:00 左側躺

(Kiri ➔ Terlentang ➔ Kanan ➔ Terlentang ➔ Kiri)

關鍵擺位要點 / Titik Kunci Penempatan Bantal

繁體中文：

- **30度側臥位**，切忌 90 度垂直側壓（會壓傷大轉子骨，造成深層壓瘡）
- **背部支撐**：背後塞入三角枕或厚毛巾卷支撐脊椎
- **兩腿之間夾枕頭**：兩膝內側、腳踝之間必須夾小枕頭，避免骨頭磨擦破皮
- **腳後跟懸空**：腳踝下方墊薄枕頭，讓雙腳後跟懸空不著床面
- **皮膚檢查**：每次翻身時，仔細檢查尾骶骨、骨盆兩側、腳後跟有無發紅或破皮

Bahasa Indonesia：

- **Miring 30 derajat saja**, JANGAN miring 90 derajat (akan menekan tulang pinggul luar)
- **Penyangga punggung**: Selipkan bantal segitiga atau gulungan handuk tebal
- **Selipkan bantal di antara kedua kaki**: Agar kulit dan tulang tidak bergesekan
- **Tumit tidak boleh menempel**: Beri ganjalan bantal kecil di bawah pergelangan kaki
- **Pemeriksaan kulit**: Setiap kali balikkan badan, periksa tulang ekor, pinggul, dan tumit

八、【雙語 SOP 1】生命徵象量測與警訊通報

SOP 1: Mengukur Tanda Vital & Tanda Bahaya

每日固定量測時間 (Jadwal Pengukuran Rutin)

時間 (Waktu)：07:00（晨起）、19:00（晚間）。若有發燒或不適，每 2–4 小時加測一次。

量測項目 (Yang Diukur)：

- 體溫 (Suhu Tubuh / T)：正常 **36.0°C – 37.4°C**
- 血壓 (Tekanan Darah / BP)：收縮壓 **100–140** / 舒張壓 **60–90** mmHg
- 心跳脈搏 (Denyut Nadi / HR)：每分鐘 **60–100** 次
- 血氧濃度 (Saturasi Oksigen / SpO2)：需維持 **≥ 95%**

警訊指標與處置 (Kondisi Bahaya & Tindakan Darurat)

狀況 / Gejala	數值警戒	處置行動 / Tindakan
發燒 / Demam Tinggi	體溫 > 38.0°C	換下厚衣、冰枕敷額、即時通知家屬 (Kompres dingin, laporkan ke majikan)
低血氧 / Napas Sesak	SpO2 < 92% 或唇色發紫	床頭搖高 45 度、抽痰、給予氧氣，未改善叫 119
血壓極端異常 / Tensi Abnormal	收縮壓 > 160 或 < 90	休息 15 分鐘後重新量測，持續異常通知家屬
突發抽搐 / Kejang	身體抽搐、眼神偏斜	**不可塞東西入口！** 側臥防嗆，立即叫 119

九、【雙語 SOP 2】鼻胃管給藥與防塞管

SOP 2: Memberikan Obat Lewat Selang NGT

步驟一：藥物準備與研磨 / Persiapan Obat

- **核對時段**：比對早、中、晚、睡前藥盒標籤，確認長輩姓名與日期
- **分開磨粉**：服藥前 10 分鐘再研磨成極細粉末
- **溫水溶解**：以約 20–30ml 溫開水（勿用滾燙熱水）徹底攪拌溶解

步驟二：床頭抬高與管路給藥 / Posisi & Masuk Obat

- 床頭搖高 **30–45 度**，嚴禁平躺灌藥
- 灌藥針筒緩慢注入藥水，利用重力自然流入
- 若有膠囊或未完全溶解顆粒，**不可硬推針筒**，避免塞管

步驟三：溫水沖管洗淨 / Bilas Air Hangat

- 藥物注入完畢後，立即注入 **30–50ml** 溫開水徹底沖洗管路
- 確認整條鼻胃管內壁透明無黃色/白色藥粉殘留
- 灌藥後維持坐姿至少 **30 分鐘**，不可立刻躺平

十、【雙語 SOP 3】床上擦澡、口腔與皮膚照護

SOP 3: Mandi di Tempat Tidur & Perawatan Mulut

口腔海綿棒清潔（每日早晚各一次）/ Perawatan Mulut

目的：無意識長輩無法吞口水，口腔容易滋生細菌導致吸入性肺炎

- 床頭抬高 30 度，頭偏向一側
- 海綿棒沾濕後「**務必擠乾**」（太濕會嗆到喉嚨）
- 輕柔擦拭牙齒外側、內側、牙齦、舌苔與上顎
- 每擦完一區更換一支海綿棒，擦完後嘴唇塗抹凡士林防乾裂

床上溫水擦澡 / Lap Badan di Tempat Tidur

- **水溫測試**：約 40°C–42°C，用手肘內側試溫
- **順序**：臉部（不加肥皂）➔ 頸部 ➔ 雙手雙臂 ➔ 胸腹部 ➔ 雙腿 ➔ 背部與臀部
- **皺褶重點**：頸部夾層、腋下、手心（扳開握拳處）、腹股溝
- **皮膚檢查**：擦乾後全身塗抹無香精潤膚乳液，特別檢查尾骶骨、腳後跟、髖骨兩側

十一、【雙語 SOP 4】導尿管與排泄照護

SOP 4: Perawatan Kateter Urin & Pembuangan Air Besar/Kecil

導尿管日常照護原則 / Aturan Selang Kencing

- **尿袋位置永遠低於腰部 / 床緣** (Kantong Urin Selalu di Bawah Pinggang) → 尿袋若高於膀胱，尿液會倒流，引發嚴重腎臟及泌尿道感染
- **定時排空** (Kosongkan Kantong Urin)：達 1/2 至 2/3 滿時必須放水，開口不可碰觸髒污地板
- 每日記錄總尿量（正常 24 小時 1200ml–2000ml）
- **每日會陰清洗**：溫水由尿道口向外**單向**擦拭管路約 5–10 公分，嚴禁由外往回擦

尿液與排便警訊對照表 / Tanda Bahaya Kencing & BAB

異常項目 / Gejala	觀察情況	應對方法 / Tindakan
尿量驟減 / Air Kencing Sedikit	連續 4 小時尿袋完全無尿	1. 檢查尿管是否被壓住或扭曲 2. 輕微擠壓排除阻塞 3. 仍無尿立刻通知家屬
尿液混濁 / 血尿 / Warna Keruh/Darah	深茶色、白色混濁沉澱物或鮮紅血尿	拍照留存，通知家屬（可能泌尿道感染或結石）
便秘超過 2 天 / Tidak BAB 2–3 Hari	連續 2 天未排便，肚子硬脹	順時針按摩腹部 10 分鐘，通知家屬依醫囑用通便塞劑
腹瀉 / Diare (Mencret)	每日排稀水便超過 3 次	便後立即溫水洗淨吹乾，塗厚層氧化鋅軟膏隔離，通知家屬

十二、印尼文日常照護常用單字速查卡

Kamus Ringkas Sehari-hari

中文	印尼文 (Bahasa Indonesia)	備註說明
量血壓	Ukur Tensi / Tekanan Darah	早晚各一次 (Pagi & Sore)
量體溫	Ukur Suhu Badan / Termometer	超過 38°C 需回報 (Di atas 38°C lapor)
血氧濃度	Saturasi Oksigen (SpO2)	需維持 95% 以上 (Harus > 95%)
給藥 / 吃藥	Minum Obat / Masuk Obat	溫水沖淨管路 (Bilas air hangat)
床上擦澡	Lap Badan di Tempat Tidur	試水溫、檢查皮膚 (Cek kulit)
清潔口腔	Bersihkan Mulut	海綿棒微濕不可滴水 (Jangan terlalu basah)
倒尿袋	Buang Air Kencing	尿袋不可放高於床 (Jangan angkat tinggi)
排便 / 大便	Buang Air Besar (BAB)	記錄次數與軟硬 (Catat di buku)
抽痰	Sedot Lendir / Dahak	呼吸急促時進行 (Jika napas bunyi)
翻身	Miringkan Badan	每 2 小時一次 (Setiap 2 jam)
灌食	Sonde Makan / Makan Lewat Selang	床頭抬高 30–45 度 (Kepala naik 30–45°)
壓瘡 / 褥瘡	Luka Tekan / Luka Dekubitus	檢查骨突處 (Cek tulang yang menonjol)
緊急打 119	Telepon 119 (Darurat)	呼吸停止、抽搐、意識驟變